

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS DE RETIRADA DE BENZODIACEPINAS (BWSQ)

Eje VI: Farmacovigilancia y Adicciones Físicas • Síndrome de Abstinencia a BZD de Peter Tyrer

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Síntomas de Retirada de Benzodiazepinas (BWSQ; autoinforme).
Nombre Original	Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire (BWSQ; Tyrer, Murphy & O'Neill, 1990).
Autores Originales	Peter Tyrer, M.D., FRCPsych, D. Murphy y I. O'Neill (St. Mary's Hospital Medical School, Londres).
Adaptaciones Hispanas	Bobes et al. (2002); Bulbena et al.; Socidrogalcohol; validación clínica en España.
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Farmacovigilancia y Sustancias. Síntomas físicos y perceptivos de abstinencia a BZD.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme estructurado específico para procesos de deshabitación.
Composición de Ítems	20 ítems evaluados en escala Likert de 3 opciones (0 a 2; rango 0 a 40 puntos).
Población y Rango	Adultos y personas mayores en proceso de reducción o suspensión de benzodiazepinas o hipnóticos Z.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos de cumplimentación autónoma o guiada en consulta médica/psicológica.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para la práctica clínica de salud mental y adicciones sin restricciones.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL SÍNDROME DE DISCONTINUACIÓN DE BZD

El **BWSQ** fue diseñado por Peter Tyrer para caracterizar el perfil neurofisiológico de la privación de agonistas alostéricos del receptor GABA-A:

- Diferenciación de la Ansiedad Rebotante:** Permite discernir si el paciente experimenta un retorno de su trastorno de ansiedad original o si está sufriendo un verdadero síndrome farmacológico de abstinencia a benzodiazepinas.
- Síntomas Perceptivos Marcadores:** Los síntomas característicos de la abstinencia a BZD no son simplemente nerviosismo, sino **alteraciones sensoriales aberrantes**: hiperacusia, hipersensibilidad visual, parestesias, despersonalización, sensación de suelo inestable o bamboleo y sabor metálico amargo.
- Guía de Titulación Segura (Protocolo Ashton):** Monitoriza la velocidad adecuada de sustitución por diazepam y desescalada gradual, previniendo convulsiones y delirio tremens por privación abrupta.

3. SÍNTOMAS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (20 ÍTEMS)

Dimensión Clínica	Nº Ítems	Manifestaciones Fisiopatológicas de Deprivación GABAérgica
1. Alteraciones Sensoriales	6 reactivos	Hipersensibilidad auditiva al ruido, fobia, parestesias/hormigueos, olor acre y sabor metálico.
2. Distorsiones Perceptivas	4 reactivos	Sensación de movimiento corporal o balanceo de suelo, despersonalización y extrañeza del entorno.
3. Síntomas Motores	4 reactivos	Temblores involuntarios de manos, sacudidas musculares breves, calambres y rigidez.
4. Síntomas Gastrointestinales	3 reactivos	Náuseas matutinas, pérdida marcada del apetito y molestias gástricas difusas.
5. Afecto y Sueño	3 reactivos	Insomnio de rebote severo, irritabilidad intensa e inquietud motriz interna.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las investigaciones clínicas psicométricas (Tyrer et al., 1990; Bobes et al., 2002; $N > 400$) avalan su exactitud:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.88 - 0.92	Elevada cohesión psicométrica en los 20 reactivos de abstinencia.
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.84$	Alta reproducibilidad en días consecutivos con pautas de dosis fijas.
Sensibilidad al Retiro BZD	Sensibilidad = 91%	Captura inmediata de picos de hiperactividad noradrenérgica y GABA.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 88%	Diferencia nítidamente la abstinencia de la recaída del trastorno ansioso basal.
Validez Concurrente	$r = 0.72$ con CIWA-B	Fuerte correlación convergente con la escala clínica de abstinencia a sedantes.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Opciones de Puntuación:** Cada síntoma se califica en escala de 3 puntos: 0 = Ausente; 1 = Moderado (síntoma presente pero tolerable); 2 = Severo (síntoma incapacitante o muy perturbador).
- **Cálculo de la Puntuación Total BWSQ:** Sumatoria directa de los 20 reactivos:

$$\text{Puntuación Total BWSQ} = \sum_{i=1}^{20} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 40 puntos})$$

- **Direccionalidad:** A mayor puntuación, mayor gravedad del síndrome de abstinencia neurobiológica.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Intensidad	Significación Clínica y Conducta Médica (Tyrer)
Ausencia / Mínima	0 a 5 puntos	Leve	Retirada bien tolerada; mantener el ritmo de reducción pautado.
Abstinencia Leve	6 a 12 puntos	Moderada	Síntomas leves de privación; ralentizar discretamente la desescalada.
Abstinencia Moderada	13 a 19 puntos	Clínica (Corte)	Punto de corte de alerta detener bajada; mantener dosis actual 2 semanas.
Abstinencia Severa	>= 20 puntos	Severa Riesgo	Riesgo neurológico alto reiniciar dosis previa y pautar equivalencia diazepam.

PUNTO DE CORTE DE SEGURIDAD (BWSQ >= 13 PUNTOS):

Una puntuación **>= 13 puntos** indica que la velocidad de reducción del fármaco sobrepasa la capacidad de neuroadaptación de los receptores GABA-A. Puntuaciones **>= 20 puntos** conllevan riesgo inminente de crisis comiciales o cuadros confusionales; se debe frenar de inmediato la retirada y reinstaurar la dosis precedente antes de reiniciar un descenso más lento.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DESHABITUACIÓN GRADUAL DE BENZODIACEPINAS

PROTOCOLO DE DESESCALADA SEGURA CON EL BWSQ (MÉTODO ASHTON):

- **Paso 1 (Conversión a Fármaco de Vida Media Larga):** Si el paciente consume benzodiazepinas de alta potencia y vida media corta (alprazolam, lorazepam), realizar la equivalencia a **Diazepam** en dosis fraccionadas.
- **Paso 2 (Monitorización Quincenal con BWSQ):**
 - **BWSQ ≤ 5 puntos:** Reducción semanal del 10% al 15% de la dosis total de diazepam.
 - **BWSQ 6 a 12 puntos:** Mantener la dosis actual durante dos semanas adicionales hasta estabilizar la puntuación en < 5 antes del siguiente escalón.
 - **BWSQ ≥ 13 puntos:** Pausar el descenso; pautar coadyuvantes no gabaérgicos (pregabalina a dosis bajas o melatonina de liberación prolongada) para el insomnio.
- **Paso 3 (Retirada Definitiva y Prevención de Recaidas):** Al alcanzar los 2 mg de diazepam/día, espaciar a días alternos antes de la supresión final.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: SUPRESIÓN ABRUPTA DE LORAZEPAM

Identificación: Mujer de 58 años consumidora crónica de Lorazepam (3 mg/día) durante 8 años. Tras leer artículos sobre demencia, decidió suspender el fármaco por su cuenta de forma repentina ("de un día para otro"). A las 72 horas acude a urgencias con desorientación, temblores e intolerancia a la luz.

Evaluación en Urgencias con el BWSQ:

- **Puntuación Total BWSQ = 27 / 40 puntos (Síndrome de Abstinencia Severo de Alto Riesgo).**
- **Desglose Sintomático:** Puntuaciones máximas de 2 (severo) en fotofobia ("la luz de la bombilla me quema los ojos"), hiperacusia dolorosa al cerrar puertas, sabor amargo metálico, temblores en ambas manos e insomnio total de 3 días.

Diagnóstico Diferencial: Síndrome de abstinencia agudo a benzodiazepinas de vida media intermedia con riesgo inminente de estatus epiléptico.

Manejo Médico: Reintroducción inmediata de Lorazepam 1 mg para frenar el cuadro agudo, seguido de transferencia a Diazepam 20 mg/día (equivalente terapéutico), iniciando un programa ambulatorio reglado de desescalada lenta a razón de 2 mg cada dos semanas. A las 48 horas de la pauta de rescate, el BWSQ descendió a 3 puntos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

PROHIBIDA LA RETIRADA BRUSCA:

La supresión súbita de BZD en consumidores crónicos puede desencadenar convulsiones tónico-clónicas y psicosis confuso-onírica grave.

HIPÓTESIS DE HIPERACUSIA:

La presencia de hiperacusia y sabor metálico es prácticamente patognomónica de abstinencia BZD, diferenciándola de un ataque de pánico puro.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Tyrer, P., Murphy, S., & O'Neill, I. (1990). The Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire. *Journal of Affective Disorders*, 19(4), 253-261.
2. Ashton, H. (1991). Protracted withdrawal syndromes from benzodiazepines. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 8(1-2), 19-28.
3. Bobes, J., et al. (2002). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica*. Ars Médica.
4. Lader, M., & Tylee, A. (2009). Withdrawing benzodiazepines in primary care. *CNS Drugs*, 23(1), 19-34.